



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صباح غانم مصطفى حبيب
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : اوسيم
رقم البطاقة : 26903032102105 رقم التليفون : 01112023658
العنوان : اوسيم
العمر (تاريخ الميلاد) : 03-03-1969 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالمستقيم
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : ورم خبيث بالمستقيم
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الاورام [11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صباح غانم مصطفى حبيب National ID: 26903032102105	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of colorectal cancer for Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحليل الشخصية

صباح
غانم مصطفى حبيب
قرية البراجيل
مركز أوسيم - الجيزة

١٩٦٩/٠٣/٢١
٢٦٩٠٣٠٣٢١٠٢١٠٢

L25602580

National ID - Front
[[DOC: PEID_Front]]

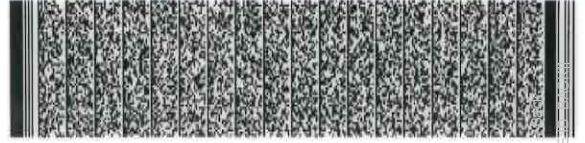


٢٠٢٦/٠٩ ٢٦٩٠٣٠٣٢١٠٢١٠٥

ربة منزل



انثى مسلمة متزوجة
عبدالواسط عبدالمنعم اسماعيل حمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٩/٢٥



National ID
[DOCT PE]



الدكتور / أحمد الحناوي

أستاذ الباثولوجي بكلية الطب - جامعة القاهرة

زميل جامعة نورث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية

3 W 810

PATHOLOGY REPORT

Name: صباح غاثم مصطفى حبيب

Age: 56 Y

Sex: Female

Referred by: أ.د. باسم & أ.د. محمد سيد

Clinical data: Recto-sigmoid circumferential mass.

Nature of the specimen: Colonoscopic biopsy.

Date specimen received: 21/9/2026

GROSS: Multiple tiny tissue fragments of endoscopic biopsy specimen; collectively measured 0.7X0.5X0.1 cm, totally submitted and serially sectioned.

MICRO: Microscopic examination of the specimen revealed fragments of tubulo-villous adenoma included foci of well differentiated adenocarcinoma (malignant transformation). The surface showed ulcerated foci. The epithelial lining of the component glands and the covering of the villous projections was closely-packed showed pseudostratification and frequent foci of high grade dysplasia. The glands in malignant foci were infiltrative and associated with fibrotic stromal reaction; their epithelial lining showed mild nuclear anaplasia.

DIAGNOSIS: RECTO-SIGMOID MASS, ENDOSCOPIC BIOPSY: **TUBULO-VILLOUS ADENOMATOUS POLYP WITH HIGH GRADE DYSPLASIA AND MALIGNANT TRANSFORMATION (INVASIVE ADENOCARCINOMA, GRADE "I").**

Signature
Prof. Dr. Ahmed El Hennawy



Name :
Referred by
Indication

Age : y
صباح غانم

~~COLONOSCOPY~~ REPORT

Consent: Procedure, alternatives, risks and benefits discussed & consent obtained from the patient.

gently inserted into the rectum and under direct visualization advanced to the extend examination. the patient tolerate the procedure well. after completion of the examination the patient transferred to recovery room .

Colonoscopy:

The patient was not well prepared as soft stool covered some of the examined mucosa, However Lower GI endoscopy up to the terminal 5 cm of the ileum was done and revealed circumferencial mass in the rectosigmoid junction (Biopsied) and 4 grade II internal piles.

Conclusion

Colonic mass in the rectosigmoid junction. (?? malignant)
(Biopsied)
Internal piles

٢٧ ٦٠٤٢٠٧
٢٧ ٦٠٤٢٠٨

تليفون

Much obliged
ENDOSCOPIST
Dr .Mohamed Sayed, M.D.



الدكتور / أحمد الحناوي
استاذ الباثولوجي بكلية الطب - جامعة القاهرة
زبيل جامعة نوريث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية

3 W 810

PATHOLOGY REPORT

Name: صباح غانم مصطفى حبيب

Age: 56 Y

Sex: Female

Referred by: أ.د. محمد سيد

Clinical data: Recto-sigmoid circumferential mass.

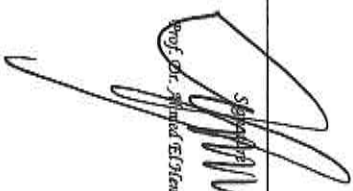
Nature of the specimen: Colonoscopic biopsy.

Date specimen received: 21/9/2026

GROSS: Multiple tiny tissue fragments of endoscopic biopsy specimen; collectively measured 0.7X0.5X0.1 cm, totally submitted and serially sectioned.

MICRO: Microscopic examination of the specimen revealed fragments of tubulo-villous adenoma included foci of well differentiated adenocarcinoma (malignant transformation). The surface showed ulcerated foci. The epithelial lining of the component glands and the covering of the villous projections was closely-packed showed pseudostratification and frequent foci of high grade dysplasia. The glands in malignant foci were infiltrative and associated with fibrotic stromal reaction; their epithelial lining showed mild nuclear anaplasia.

DIAGNOSIS: RECTO-SIGMOID MASS, ENDOSCOPIC BIOPSY: TUBULO-VILLOUS ADENOMATOUS POLYP WITH HIGH GRADE DYSPLASIA AND MALIGNANT TRANSFORMATION (INVASIVE ADENOCARCINOMA, GRADE "1").


Prof. Dr. Ahmed ElShennawy